突然的精神冲击

英格兰和威尔士过失侵权法中的精神损害。区分旧的突然冲击要求、Sion 与 Ronayne 案，以及 Paul [2024] UKSC 1 对旧说法的纠正。

1. 把旧术语放回历史背景

过去的案件常把次级受害人的精神疾病解释为 nervous shock（神经性休克或精神震惊）：突然看见或听见亲人遭遇可怕事件后，产生强烈反应。法院把这种情况与在亲人逐渐病重时长期积累的担忧区分开。

在 Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310 中，Lord Ackner 用“突然感知恐怖事件并猛烈扰乱心智”的说法描述冲击。后来的法院把这种表述当作独立法律限制。理解旧案时要知道这一点，但不能把它当作2024年之后的完整规则。[1]

> 现行规则：Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 否定了“神经系统受到突然冲击”这一独立附加要求，也否定了另行判断事件是否“足够恐怖”的测试。今天不能再把两者列为额外索赔条件。[1，第71-78段]

2. 哪些条件仍然存在？

精神疾病索赔仍须有医学认可的疾病，并证明它与被告违反注意义务之间的因果关系。一般的悲伤、恐惧和难过不够。不能因为亲人受苦，就认定原告一定患有精神疾病；必须证明原告本人的疾病。

在既有的次级受害人事故类别中，相关注意义务、可预见性和 Alcock 限制条件仍然重要：密切的爱与感情联系；与事故或其直接后续情形在时间、空间上接近；亲身感知，而非仅听别人转述。[1]

3. 不要混淆三个问题

医学问题：原告患有什么病？因果问题：什么经历造成了这个病？法律问题：被告对这位原告是否负有相关义务？请求失败不等于疾病是假的；同情也不能代替诊断或责任证明。

本指南讨论次级受害人的精神损害请求，不是把所有事故类别的限制套用到一切情形，例如员工因工作压力产生的本人索赔。

早期的医疗案件

4. Sion v Hampstead Health Authority (1994)

发生了什么？一名年轻人在摩托车事故中受伤后住院。他的父亲在床边陪伴十四天，看着他逐渐恶化、昏迷并死亡。父亲主张，医院疏忽地没有发现持续的内出血，造成儿子死亡及自己患上精神疾病。

被告是谁？是医院管理机构，不是交通事故的责任人。这个区别很重要：请求针对的是父亲经历的住院治疗和病情恶化，不能写成"父亲亲眼看见原来碰撞后起诉肇事者"。

谁胜诉？为什么？原告的请求在初步阶段被排除，Court of Appeal 维持该结果。根据当时使用的冲击要求，疾病来自逐步发展的过程，而非突然的冲击事件；死亡发生时已经可以预期。相关医疗过失只是为这项初步法律审查作假定，并非经过完整审判后确定。[1，第62-63段]

5. Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne

案号：[2015] EWCA Civ 588。Ronayne 女士手术中的过失造成严重疾病，需要紧急治疗。丈夫先看见她在再次手术前连接医疗设备，后来又看见她昏迷、使用呼吸机、严重肿胀。经过长期重症监护，她最终康复。

诊断要准确：丈夫主张患有 PTSD（创伤后应激障碍）。一审法官没有认定这一诊断成立，但认定有精神疾病；上诉中以适应障碍来处理。不能因为转录文本写了 PTSD，就说法院已经确认了 PTSD。

谁胜诉？丈夫一审胜诉，但医院上诉成功，丈夫最终败诉。Court of Appeal 使用旧的"突然冲击"和"恐怖事件"分析，认为他经历的是一系列令人痛苦的情形，而非所要求的突然体验，并质疑一审的因果分析。[2]

今天如何使用这些判例：先说明当年的裁判，再解释 Paul 的纠正。旧的冲击论证不再是独立现行测试；取消它，不会自动推翻原结果，也不会自动证明其他责任条件。

Paul 判决之后的规则

6. Paul：证明因果关系，不必证明额外冲击机制

2024年1月11日，最高法院说明：Alcock 中关于突然冲击的表述，并未设立一项额外责任限制。原告不必证明“看见事故如何通过某个特定神经或心理机制导致疾病”。但目睹事故与疾病之间的因果联系本身，仍必须证明。[1，第73-74段]

法院也拒绝另设事件必须“有多恐怖”的门槛。这与精神疾病在原告所处情况下是否合理可预见，是不同问题。取消恐怖程度测试，不等于取消可预见性要求。[1，第75-78段]

7. 晚些诊断，不等于长期积累的担忧

虚构例子 A：母亲看见过失造成的碰撞，孩子严重受伤。症状在后来出现，数月后才获诊断。仅因诊断较晚，不能否定请求；她仍须证明医学认可的疾病、因果关系及其余条件。

虚构例子 B：家属数周内反复探望逐渐病重的患者，自己也患病。取消突然冲击要求，不等于这个请求必然成功。仍须检查注意义务、以事故为基础的边界和其他条件。

> 分开看四个时间：事故何时发生；原告何时感知事故或直接后续情形；疾病如何发展；何时确诊。法律不要求在事故现场就完成精神疾病诊断。

8. Paul 中的家属为什么仍然败诉？

最高法院驳回了 Paul、Polmear 和 Purchase 的上诉。多数意见没有把既有的事故例外扩展到所讨论的医疗危机或疾病死亡，即使它们来自更早的漏诊或治疗过失。在这些情况下，对患者的义务不包括保护家属免于这种经历造成的精神疾病。[1]

这讨论的是义务范围，不是家属的疾病是否真实；也不是说医疗过失永远不可能涉及事故。因此，讲解 Sion 和 Ronayne 时，要把历史上的冲击论证，与今天对注意义务的分析分开。

答题方法：识别旧判例的突然冲击思路 → 说明 Paul 的纠正 → 再检查疾病、因果关系、可预见性、相关事故与 Alcock 限制条件。

理解与练习

1. 突然冲击是今天次级受害人的额外必要条件吗？
答案： 不是。Paul 否定了独立的“神经系统突然冲击”要求。

2. Paul 是否取消了医学认可的疾病和因果关系？
答案： 没有。精神疾病索赔仍须证明两者。

3. Sion 的被告是谁？
答案： 医院管理机构。被指控的是摩托车事故后的治疗过失，不是这个被告的疏忽驾驶。

4. Ronayne 的结果是什么？
答案： 丈夫一审胜诉，医院上诉后丈夫败诉。法院没有认定 PTSD 成立；上诉讨论的是适应障碍。

5. 今天是否必须额外证明事件“足够恐怖”？
答案： 不必。Paul 否定了该附加测试，但疾病的合理可预见性仍然重要。

6. 数月后才确诊，是否必然使事故请求失败？
答案： 不是。诊断时间与事故是否造成疾病，是不同问题；其他条件仍须满足。

7. 取消突然冲击后，Paul 中的家属胜诉了吗？
答案： 没有。他们仍因注意义务范围及事故例外的边界而败诉。

最重要的结论

历史上：法院常要求突然的冲击或恐怖事件。Paul 之后：这些附加测试被否定；疾病、因果关系、可预见性，以及对次级受害人义务的既有边界仍然存在。

资料与延伸阅读

[1] Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust; Polmear v Royal Cornwall Hospitals NHS Trust; Purchase v Ahmed [2024] UKSC 1：第62-63段（Sion）、69-78段（Ronayne 及被否定的测试）、138-143段（医疗义务与结果）；也讨论 Alcock [1992] 1 AC 310。**最高法院判决**。

[2] Liverpool Women’s Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne [2015] EWCA Civ 588，尤其第1-9及38-48段。**Court of Appeal 判决，英国国家档案馆**。Sion v Hampstead Health Authority [1994] 5 Med LR 170 见资料[1]中的讨论。